

Au moment où j'ai cette phase de flexion, et que j'ai cette phase de redressement de mon embryon, j'ai mon tube digestif au départ qui est assez bas. Et si vous regardez maintenant votre palais, vous voyez qu'il est ogival comme ça. Mais avant, en fait, il était plutôt bas. Parce qu'au même moment que j'ai cette phase de redressement à l'intérieur, j'ai cette descente de mes ptéridoïdes vers le bas, j'ai cette montée ici, et j'ai une traction de mon tube digestif qui fait ceci, qui monte. Donc elle est là, et dans ce développement, ça fait un mouvement comme ça. Là. Et en fait, qu'est-ce qui tire ? C'est le processus de développement pour la langue. Et en même temps, je vais déjà rajouter une partie qu'on appelle la thyroïde. La thyroïde vient de la langue. Dans cette coupe ici de l'embryon, ça représente ici ce qu'on appelle la partie endodermique. Et on voit l'arc pharyngien numéro 1, qui est ici, qui correspond à celui-ci. L'arc pharyngien numéro 2, 3, 4. Et on voit ici, dans l'arc pharyngien numéro 1, dans la phase de développement, et ça se fait au même moment que ma phase de redressement de l'embryon, on voit apparaître à la surface ici, en fait, ce qu'on appelle la couche de la langue latérale. Et on voit ici, entre la partie ici, ce qu'on appelle, l'arc branchien numéro 2, un tuberculum qu'on appelle le tuberculum impair. Et au bout de ce petit tuberculum ici, on voit apparaître un petit trou, un petit espace qu'on appelle le foramen sécum. Vous voyez la langue qui se développe ici. Et dans la phase de redressement ici de mon embryon, il faut bien voir que c'est beaucoup plus grand. Le petit espace ici qu'on appelle ici, eh bien, il est déjà là. C'est tout ceci qui a grandi. Et ça donne cette image. D'un trou qu'on appelle le foramen sécum, qui va former le système thyroïdien. Donc c'est une croissance globale, avec un point, cette fois-ci, qui est un point fixe qui se met ici, dans le développement. C'est comme si c'était tiré. Donc au départ, elle est là, et ça fait ça. Par rapport au développement ici. C'est là que tu as ce système ogival. C'est pour ça qu'on dit que la profondeur de la langue

représente la profondeur de l'encéphalisation. Le redressement de l'embryon, j'ai le foramen séqué qui était ici, qu'on voit piqué là, piqué là, piqué là, avec toute la formation. Une autre coupe qui nous montre le même dessin. Je vois latéralement ici ce qu'on appelle le cartilage de Meckel, la langue. Et dans la phase de redressement, il y a une erreur dans les flèches. Il faudrait mettre les flèches dans l'autre sens, pour comprendre dans la dynamique. Cette zone ici, c'est comme un déchirement, en fait, entre là et mon diaphragme. Je vais avoir comme un déchirement de mes muscles avec le cartilage thyroïde, qui devient un point d'appui pour tout ça. Donc je peux appuyer et je fais tout ce redressement ici. Par rapport à ma langue, ça veut dire que stabiliser une langue et stabiliser un air vague, c'est donner le point d'équilibre au niveau de mon cartilage thyroïde et de mon ossioïde. Ta langue, c'est ta première activité posturale. L'enfant se redresse quand il commence à avoir ses premières dents, parce que c'est des points d'appui avec sa langue. On cherche la précision avec sa langue. C'est comme les ailes de l'oiseau, de l'aigle, ton diaphragme, qui peut vraiment s'ouvrir, mais ça s'ouvre dans toute cette phase d'ouverture et d'itération, presque un déchirement des muscles du cou, avec des points d'appui spécifiques qui se fondent. Donc c'est comme ça que tout peut bien s'étendre. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche toujours ? C'est avoir nos points d'appui pour respirer. Parce que chaque fois que tu vas avaler ta salive, tu vas fermer tes dents et ta langue vient se mettre complètement à étaler. Elle vient chercher à boucher tous les petits trous. Si il te manque une dent, elle vient chercher ce contact sur le côté. Elle va bouger et donc elle va dévier ton axe. Et j'ai découvert que par rapport à cet axe longitudinal, qui est l'axe de ma ligne médiane, donc un autocordal, en rapport avec tout ce niveau-là, l'impact va très loin dans le corps et entre autres jusqu'au niveau du bassin. Et parfois, vous avez des déviations du bassin qui sont une expression d'un déséquilibre

occlusal, par rapport à ce que tu peux sur le plan lingual. C'est ce que tu vois là en fait. Et donc en remodelant, rehaussant, redonnant, le système peut retrouver ses points d'appui. Alors maintenant, pourquoi tout se met de travers ? Il y a des mémoires dans les dents en fait. C'est une zone de densification la plus forte. Donc ça veut dire qu'elle garde la charge dite karmique, comme on dit. C'est ce qui restera de toi. Donc bien comprendre cette dynamique où on voit que dans cette phase de développement, tu vois latéralement, on a ce qu'on appelle les tonsils palatins. La parathyroïde, le thymus et le corps ultimo-branchial. Et à l'intérieur ici, on a encore, depuis le foramen séqué, la thyroïde. Et qui correspond en fait à chaque arc qu'on appelle l'arc branchial mandibulaire, thyroïdien, laryngin supérieur, laryngin inférieur. C'est pas que ça part de la langue, mais ça part de tout l'espace qui est autour ici. À l'intérieur complètement ici, le tissu endodermique, donc digestif. Dans le système, le système cartilagineux. Et à l'extérieur, le système épiblastique. En quinze jours, j'ai ma notochorde. Le vingt-septième jour, j'ai la fermeture de mon tube neural complète. Vingt-huitième jour. À même temps que l'intégration. Puis après, j'ai le redressement de mon embryon qui commence à se faire complètement. Donc c'est après le premier mois. Donc toute cette phase complète se développe entre le deuxième mois et le troisième mois. Avec une chronologie spécifique. En sachant qu'à la fin du deuxième mois, tu as vraiment une forme complète d'un embryon. On pourrait dire que c'est déjà le deuxième mois de cette phase. Avec des lignes bien spécifiques et des synchronicités spécifiques. Chaque arbre encale est composé de l'extérieur vers l'intérieur. Épiblastique, ectodermique. À l'intérieur, c'est tout ce qui est mésodermique. Avec la partie cartilagineuse, vasculaire, etc. Et à l'intérieur, c'est tout ce qui est endodermique. Automatiquement, ils s'influencent. Parce que l'ectoderme et l'endoderme sont dépendants du mésoderme. Donc c'est ce qu'on

appelle le tissu d'extérieur et dépendant du tissu d'intérieur. C'est lui qui amène, c'est la voie royale qui amène l'information trophique, l'information nutritive. Vous comprenez un peu cette dynamique, comment finalement, dans cette phase de développement, la langue, la thyroïde, la parathyroïde se développent. Ce n'est qu'une réponse à cette phase de développement complète. Avec chaque fois des nouveaux points d'appui, des nouveaux fulcrums qui vont se développer. Il faut bien apprendre à suivre ces fulcrums, bien apprendre à les comprendre et à pouvoir s'orienter. Vous allez voir, dans la pratique, ça s'exprime. Quand on est dans la bonne résonance tissulaire, le corps, touc, il reconnaît. Le grand fulcrum, c'est ton nombril. Il faut que le bassin soit bien dégagé, bien libre. Ça, c'est très important. Et puis, naturellement, la SSB. C'est pour ça qu'on commence très fréquemment à traiter un bassin. Est-ce que j'ai une bonne dynamique ? Moi, je commence pratiquement toujours à regarder le bassin. Comme on avait vu, une des premières pratiques qu'on avait faites, c'était le sacrum, par rapport à cette synphyse phénobasilaire. Parce qu'elles sont unies. Donc, si je travaille un sacrum ou un bassin, finalement, je travaille déjà une synphyse phénobasilaire. On ne sait pas travailler une synphyse phénobasilaire sur la synphyse phénobasilaire. C'est comme si on travaillait toute la périphérie vers ma synphyse phénobasilaire.